Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 7ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810373

Processo nº **0014375-95.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): J. R. D. M. T.
REPRESENTANTE: ISIS FELIX DE MOURA

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE PORTADOR DE BAIXA ESTATURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. SOMATROPINA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. USO DOMICILIAR. REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA.

1. Relação de consumo reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre beneficiário e operadora de plano de saúde. Inteligência da Súmula 608 do STJ.

2. Impugnação à gratuidade da justiça indeferida.Reconhecimento da incapacidade econômica presumida do autor, menor impúbere. Precedente do STJ.

3. Negativa de cobertura médica. Medicamento prescrito por profissional especialista (Somatropina), com indicação formal para tratamento de deficiência de hormônio do crescimento em menor de idade.

4. Registro sanitário e regularidade do fármaco. Produto registrado junto à Anvisa, com indicação terapêutica reconhecida. Essencialidade comprovada. Alegação de exclusão contratual por uso domiciliar afastada diante da imprescindibilidade do tratamento.

5. Doença preexistente. Ausência de prova de diagnóstico fechado ou de ciência prévia da contratante no momento da adesão ao plano. Inexistência de perícia médica prévia ou comprovação de má-fé. Incidência da Súmula 609 do STJ e da RN nº 162/2007 da ANS.

6. Cláusula limitativa. Interpretação restritiva das exclusões de cobertura. Abusividade reconhecida à luz dos arts. 6º, I, e 51, IV, do CDC. Direito fundamental à saúde prevalente.

7. Dano moral configurado. Recusa indevida de tratamento médico essencial impõe angústia desproporcional à paciente e sua família. Dever de indenizar reconhecido.

8. Pedidos que se julgam procedentes.

João Rafael de Moura Tinoco, menor impúbere, representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face da Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico, ambos devidamente qualificados.

Consta da inicial que o autor é beneficiário de plano de saúde da ré e está em regular cumprimento das obrigações contratuais, tendo sido diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento (CID: E23.0), motivo pelo qual recebeu prescrição médica para tratamento com a medicação Somatropina (Cricsy 10 mg), essencial para seu desenvolvimento ósseo e estatural.

Alega que, apesar da necessidade médica devidamente comprovada por laudos e exames anexados à inicial, a operadora do plano de saúde recusou a cobertura do tratamento, sob justificativa de que se trata de medicamento de uso domiciliar sem previsão contratual. Argumenta que a negativa viola normas do Código de Defesa do Consumidor e contraria a jurisprudência consolidada, que reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamentos essenciais à saúde do segurado.

Defende que o medicamento prescrito está incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e que a recusa compromete seu direito fundamental à saúde, podendo resultar em danos irreparáveis. Requer, em caráter liminar, a imediata concessão da cobertura do tratamento, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação da obrigação de fornecimento do medicamento, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pugnou pela gratuidade da Justiça e juntou documentação.

Os documentos juntados incluem exames médicos, laudos periciais, orçamento do medicamento, comprovantes de pagamento do plano de saúde e a negativa formal da ré.

Foi proferida decisão sob ID nº 195258733 deferindo a mercê do art. 98, CPC, e a tutela da urgência para "*para determinar que a empresa demandada, no prazo de sete dias úteis, passe a arcar com os custos do tratamento medicamentoso requisitado na inicial, incluindo toda a aparelhagem necessária para sua ministração, durante todo o período e em estrita consonância com a solicitação do médico endocrinologista assistente*".

Regularmente citada, sob ID nº 196756957, a ré, Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico, apresentou contestação.

De início, a operadora impugna o deferimento da gratuidade de justiça, argumentando que, embora o autor seja menor impúbere, compete aos seus genitores arcar com as custas processuais.

No mérito, a operadora alega que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Argumenta que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar e, por expressa exclusão contratual e nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, excetuados os medicamentos antineoplásicos orais e os utilizados em regime de internação ou home care — hipóteses que não se aplicam à situação dos autos.

A ré sustenta, ainda, que não foi demonstrada urgência real e concreta que justifique a antecipação da tutela. Assevera que o autor possui 15 anos de idade e que eventual deficiência no hormônio do crescimento deveria ter sido investigada em momento anterior, sendo o tratamento pleiteado tardio e desprovido dos elementos técnicos exigidos pela Portaria nº 110/2010 do Ministério da Saúde. Afirma que o relatório médico juntado não apresenta dados essenciais como altura, peso, velocidade de crescimento, resultados laboratoriais e exame de imagem (ressonância magnética da hipófise), elementos considerados indispensáveis à aferição da real necessidade da terapêutica proposta.

Reforça que o fornecimento da medicação não é obrigação da operadora de saúde, mas, em caso de hipossuficiência financeira, responsabilidade do Sistema Único de Saúde – SUS, que dispõe de políticas públicas específicas para a dispensação gratuita de medicamentos de alto custo, inclusive a própria Somatropina. Argumenta que a extensão da cobertura sem respaldo contratual ou legal compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a própria sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Sob ID nº 201431922, a parte autora apresentou réplica na qual refuta todas as alegações da contestação, com destaque para a defesa da tutela de urgência concedida, a qual entende estar amplamente respaldada em laudo médico subscrito por endocrinologista pediátrica, o qual atesta expressamente o diagnóstico de deficiência de hormônio do crescimento (CID E23.0) e a necessidade urgente do medicamento Somatropina (Genotropin).

Malote digital recebido no id nº 201764965, , noticiando a concessão de efeito suspensivo À decisão proferida por este juízo

Seguiu-se despacho de ID nº 201675120 indagando os contendores sobre interesse na autocomposição ou na dilação probatória. Ainda, fora invertido o ônus da prova em desfavor da OPS demanda.

Em resposta, o demandante clamou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 203876243) e a operadora de plano de saúde silenciou (ID nº 204396527)..

Houve alegações finais reiterativas.

Do que importa, é o relato. Pronuncio-me.

De início, não vislumbro condição de prosperidade na impugnação à já concedida gratuidade da Justiça.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, presunção esta que somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário — o que não se verificou nos autos. Ademais, considerando que o autor é menor impúbere, com 15 anos de idade, presume-se a sua incapacidade financeira, o que reforça o direito à fruição do benefício.

Nesse contexto, o indeferimento ou a limitação do benefício da gratuidade da justiça apenas se justificariam caso houvesse prova nos autos de que os requerentes possuem renda própria, que lhes permita custear as despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e de sua família. Esse não é o caso aqui.

Cabe destacar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada em 06.02.2020, fixou o entendimento de que os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade devem ser preenchidos, em regra, pelo próprio autor da demanda, independentemente da condição econômica de seu representante legal.

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895603/artigo-99-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 3º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895596/paragrafo-3-artigo-99-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do novo CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15). ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos.
>
> imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância.
>
> 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.
>
> 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.
>
> 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
>
> 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.
>
> 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895603/artigo-99-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 3º

(https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895596/paragrafo-3-artigo-99-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do novo CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15), deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895603/artigo-99-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 2º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895599/paragrafo-2-artigo-99-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do novo CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15), a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1807216/SP (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/857998908), Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

Inexistindo questões prévias pendentes de apreciação, e estando por isso o feito em ordem, adentro de imediato ao mérito da causa.

De início, destaco que o contrato objeto da presente demanda — plano de assistência médica suplementar — configura típica relação de consumo, estando submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A parte autora, na qualidade de beneficiária de plano de saúde contratado para atendimento pessoal e familiar, enquadra-se como consumidora final dos serviços prestados, enquanto a ré, operadora de plano de saúde, é fornecedora de serviços remunerados no mercado de consumo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa premissa. Consoante a Súmula 608/STJ, *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

O enunciado acima orienta, de forma vinculante, que a atividade desempenhada por operadoras privadas — como é o caso da demandada — sujeita-se aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, transparência e função social do contrato.

O reconhecimento da natureza consumerista da relação impõe, ainda, a possibilidade de interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, bem como a aferição da abusividade de eventuais cláusulas restritivas, especialmente quando implicam limitação ao direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado no art. 6º, caput, e art. 196 da Constituição Federal.

Ainda neste viés, há de se destacar que, em conformidade com o regramento estampado na legislação consumerista, o direito lastreado na boa fé ostenta especial relevância em prol do consumidor, mormente quando se cuida de situação de risco no que concerne à higidez física dos pacientes (arts. 5º e 196 da Constituição Federal) situação essa que se acha patenteada no teor do documento médico que sinaliza para a necessidade de submeter a suplicante, de tenra idade avançada e vítima de baixa estatura associada à deficiência do hormônio de crescimento, à referida intervenção medicamentosa com Somatropina (Genotropin).

Com efeito, cabível assentar que a perpetuação da doença sem o devido tratamento ensejaria dano físico e social irreparável, o qual exige premente e pronta alberga judicial.

Para além disso, cumpre assentar que o CDC é norma de ordem pública (art. 5º, XXXII, da CF), sendo certo que o plano de assistência médico-hospitalar é contrato de trato sucessivo, que se renova a cada mensalidade.

A Constituição Federal assim prescreve:

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

É que entende este Juízo, em consonância com a moderna jurisprudência, que a circunspeção e seriedade da moléstia, passível de cobertura contratual como no caso, bem como o prazo para o respectivo tratamento, não podem ser aferidos pela análise administrativa da empresa seguradora. Antes, é ilação a que apenas o médico assistente pode chegar, mediante a anamnese da situação em concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que compete ao médico assistente determinar qual o tratamento que deverá ser aplicado ao paciente.

Neste viés, o Superior Tribunal de Justiça já apascentou que *"o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015*).

Consoante a Lei Consumerista, as cláusulas restritivas de direitos devem estar redigidas de maneira destacada, possibilitando assim a fácil percepção da parte contratante que, por se tratar de simples aderente e ostentar posição econômica induvidosamente inferior, qualifica-se como hipossuficiente.

Nesta esteira, inolvide-se a previsão legal contida no §4º do artigo 54 do referido diploma legal que, ao tratar dos contratos de adesão, dispõe que *"as cláusulas que implicarem limitações de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão".*

Conforme deflui da singela leitura da defesa, a ressalva material da operadora ré repousa no fato de que não estaria obrigada a custear o fármaco, por não constar de cláusula contratual e do Rol da ANS, dado ser de uso domiciliar.

Todavia, ainda que haja cláusula contratual ou dispositivo regulamentar administrativo nesse sentido, tal realidade não seria suficiente para a empresa demandada eximir-se de custear a medicação, haja vista que tal procedimento configurou-se como indispensável à higidez física da paciente.

Em razão do quadro clínico da demandante, considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do tratamento farmacológico específicoa requerido pelo médico assistente seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a vida saudável.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a cobertura do tratamento.

Assim, a operadora é obrigada a garantir o medicamento Somatropina (Genotropin).

Ainda neste segmento, julgo ser ilegal a recusa à concessão da cobertura, vez que ainda que a ANS, no seu Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não tenha incluído a Somatropina (Genotropin) para déficit de crescimento ou mesmo deste não constar nas diretrizes de utilização para o procedimento necessário ao paciente, cuido tratar-se de listagem meramente exemplificativa e de cobertura mínima, não devendo ser considerada taxativa a excluir a responsabilidade de fornecimento do tratamento, sendo a negativa incompatível com os princípios da equidade e boa-fé.

A este respeito, recentemente, caiu por terra a discussão existente sobre a taxatividade do Rol da ANS e a obrigatoriedade de custeio de tratamentos não previstos na lista ofertada pela Agência Reguladora.

A já mencionada Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656, de 1998 (http://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1998-06-03;9656), estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RPES), atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Desta feita, acha-se definitivamente profligado o entendimento pelo "rol taxativo" para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos ainda que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Tratamentos fora dessa lista deverão ser aceitos, desde que cumpram uma das condicionantes: ter eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou ter recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

Vejamos:

> *Art. 10. (...)*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*

> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

É bem esse o caso dos autos.

Em efeito, importa destacar que o fármaco em questão possui registro ativo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, sob o número 1.1013.0045, estando classificado como medicamento biológico sujeito à prescrição médica e com comercialização regular autorizada no território nacional.

Conforme consta no banco de dados oficial da Anvisa, o medicamento é aprovado para múltiplas indicações clínicas, dentre as quais se inclui expressamente a deficiência de hormônio do crescimento em crianças e adolescentes, quadro que fundamenta a prescrição nos autos. Sua via de administração é subcutânea, e sua aplicação é rotineiramente realizada em ambiente ambulatorial ou domiciliar, sob acompanhamento especializado.

A existência de registro sanitário vigente atesta a segurança, eficácia e qualidade do medicamento, nos termos da legislação federal de vigilância sanitária, afastando qualquer dúvida quanto à sua licitude ou adequação terapêutica. Nessa perspectiva, mostra-se indevida a negativa de cobertura baseada em suposta ausência de previsão contratual ou por tratar-se de medicamento de uso extrahospitalar, uma vez que se trata de medicamento essencial prescrito com fundamento técnico e regulação sanitária compatível.

Por isso, entendo que a mencionada negativa, ainda que lastreada em anteparo contratual, não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Nos contratos onde existem cláusulas que venham prejudicar a parte mais fraca da relação de consumo, em detrimento das máximas da boa-fé objetiva e da confiança, há que se as considerar abusivas, devendo ser reconhecidas judicialmente por meio de ação ou reconvenção, de exceção ou por ato *ex officio* do Juiz.

O artigo 51, incisos IV e IX do CDC, dispõe:

> *Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)*
>
> *IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a eqüidade; (...)*
>
> *IX deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor.*

Inobstante tal realidade, a empresa demandada persistiu em negar a cobertura do tratamento integral, sugerindo reembolsá-lo apenas parcialmente, nada obstante não ostente estabelecimento e profissionais vinculados capacitados para tanto, olvidando assim as garantias constitucionais e da legislação consumerista.

Sopesando, em conclusão todos os argumentos expendidos, tenho que se afeiçoa induvidoso que o pleito formulado pela autora merece acolhimento.

Por outro lado, a exclusão do dever de cobertura por cláusula contratual ou instrumentos de convênio firmados com terceiros, malgrado descrita em supostos estudos atuariais, constitui indisfarçável e frontal violação do regramento estampado na legislação protetiva do hipossuficiente porquanto soa implausível, eivada a não mais poder de abusividade e, *pour cète cause*, nula de pleno direito, o que fica aqui expressamente reconhecido e declarado, na forma do art. 52 inc. IV da Lei 8.078/1990, e art. 168 par. único do CC (antigo, art. 146 par. único).

Não se pode olvidar que, imbuída da mais intangível boa-fé, acedeu a parte autora às letras previamente anotadas pela seguradora na esperança de ver resguardados seus direitos e liberdades constitucionais, no que dizem com sua dignidade, vida e incolumidade física e mental. Decerto, perseguir valores indevidos ou negar cobertura securitária quando se evidencia negligência ou mesmo cavilosidade na arguição do dispositivo da avença concernente à imprevisão no ajuste é clausular a iniquidade e a abusividade, o que, face à ordem normativa consumerista, não pode prosperar.

Por isso, entendo que a mencionada negativa, ainda que lastreada em anteparo contratual ou no parecer de médicos de comitê subordinado à operadora, não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização do seu tratamento nos exatos moldes indicados pelo médico assistente.

É de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida localizado no caput do art. 5º da CF, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional.

Para além da estreita relação com o direito à vida, o direito à assistência à saúde possui intrínseca relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, razão pela qual, conclui-se, qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo Poder Público que provoquem o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois vetores considerados igualmente fundamentais pela Constituição.

Em nosso País, o direito à existência digna é refletido, entre outros aspectos, pela obrigação atribuída a quem quer que seja (Estado, operadoras de planos de saúde suplementar etc.) de realizar ações integradas destinadas a assegurar a prestação dos direitos inerentes à saúde, à previdência e à assistência social, incluídas, nesse contexto, ações que garantam acesso universal igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim é que qualquer omissão no papel de garantidor desse direito abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.

No caso vertente, verificando os fatos e argumentos expendidos na exordial e os documentos acostados, não sobeja dúvida que o pacto firmado entre os litigantes reveste-se da roupagem estritamente adesiva. Por outro lado, é cristalino que o caso *sub judice* versa sobre uma relação de consumo, devendo, portanto, ser observado o Código de Defesa do Consumidor.

Destaco ainda que, nada obstante a letra fria do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, o fato de o medicamento ser de uso domiciliar, não afasta o dever de cobertura, no caso concreto.

Apoiando este pensar, confira-se:

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. PRECEDENTES. DANO MORAL CABIMENTO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.*
>
> *(...)*
>
> *2. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes.*
>
> *3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que configura óbice da Súmula nº 7 do STJ.*
>
> *(...)*
>
> *(AgInt no AREsp 1285474/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)*
>
> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO.*
>
> *1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.*
>
> *2. Agravo interno a que se nega provimento.*
>
> *(AgInt no AREsp 1064435/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)*

Da Corte Pernambucana, colaciono:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. USO EM AMBIENTE DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO INERENTE AO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO À SAÚDE DA PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DA SEGURADORA.*
>
> *1. A controvérsia a ser dirimida nestes autos está restrita ao cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do CPC/2015, portanto, está atrelada à questão estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa natureza, sendo que as demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e devem ser analisadas em momento oportuno.*

2. In casu, agravante foi diagnosticado com Baixa Estatura Idiopática (CID E34.3), sendo necessário, segundo laudo médico, o uso de bloqueador de puberdade e estimulação hormonal de crescimento.

3. É ilegal/abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento requerido, uma vez que compete ao especialista responsável por acompanhar o paciente, e não ao plano de saúde, eleger qual o tratamento necessário e adequado à sua cura/melhora/sobrevivência. Negar tal cobertura fere o princípio da boa-fé, indo de encontro à própria finalidade do contrato, haja vista que restringe direitos/obrigações fundamentais do contrato de seguro saúde e impõe desvantagem excessiva ao beneficiário. Ofensa aos arts. 6º, IV; 39, V; e 51, IV e §1º, II, do CDC.

4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde - Lei 14.454/2021, não tendo sido indicado pela OPS substituto terapêutico.

5. Agravo de Instrumento a que se dá provimento. Prejudicado o Agravo Interno.

(TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0023496-73.2023.8.17.9000, Rel. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC), julgado em 30/04/2024, DJe)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES DA 1ª CÂMARA CÍVEL DO TJPE.

1. A recente Resolução Normativa 465 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde - ANS, revogou a RN 428/2017, incluindo o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol e Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I (Pág. 62), o qual elenca os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória. Dessa forma, a seguradora está obrigada ao fornecimento do hormônio do crescimento por expressa previsão da RN. 465/2021, pois o tratamento é de cobertura obrigatória e deve constar no contrato. Precedentes da 1ª Câmara Cível do TJPE.

2. Apelação a que se dá parcial provimento.

(TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0105316-33.2021.8.17.2001, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em 30/04/2024, DJe)

Por fim, não se pode negar que, em princípio, devem ser atendidas as Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ocorre que, ante o caráter exemplificativo dessa lista de procedimentos, também suas diretrizes devem ser encaradas *cum granum salis*, posto que, como é cediço, a norma jurídica anda a pé, enquanto o fato social corre a cavalo.

Amparando essa ilação, confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME ONCOLÓGICO. PET SCAN. CONSUMIDORA DIAGNOSTICADA COM TUMOR NEUROENDÓCRINO. ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de consumidora diagnosticada com tumor neuroendócrino com indícios de metástase, a indicação de exame PET-SCAN deve ser autorizada pela operadora de plano de saúde, por adequação às Diretrizes de Utilização – DUT do Rol de Procedimentos da ANS.

2. Ainda assim, independentemente de adequação às DUT, o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS torna obrigatória a cobertura do exame requisitado, uma vez que se trata de procedimento previsto como obrigatório.

3. Recurso desprovido.

(TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0001590-47.2020.8.17.9480, Rel. RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior, julgado em 23/02/2022, DJe)

Por fim, quanto ao pedido indenizatório, exsurge nitidamente que ele merece prosperar nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela recusa velada e pela expressa negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicadíssimo da parte autora, objetivo primordial dos procedimentos médicos irregularmente dificultados e vetados.

Respeitante ao pedido alusivo aos danos morais, permite-se este Juízo deixar assentada breve conceituação pela qual "*danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico*" (SILVA, Wilson de Melo da. O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1995, n° 01).

Por certo, infligir ao paciente – uma criança debilitada pela moléstia que lhe acomete - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe com absurda iniquidade a aprazia e o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

O lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material, espiritual ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

A jurisprudência da Corte Estadual, ademais, foi pacificada no sentido de que a negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde rende ensejo à indenização por dano moral (Súmula 35 do TJPE).

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte ré em autorizar o exato e integral tratamento de saúde parte da autora e em cobrir todas as despesas com o tratamento médico do paciente nos termos solicitado pelo médico assistente, devendo suportar os custos com a cobertura devida em relação ao contrato celebrado entre as partes, por abusiva restrição, além da indenização por dano moral, este arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a intensa extensão do dano suportado pelo demandante e as condições pessoais das partes, com atenção ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, cumpre assentar, por conveniente, que a fixação dos danos morais em montante inferior àquele pretendido pela parte na peça de ingresso não importa sucumbência recíproca, nos exatos termos da Súmula 326, STJ.

Isto posto e por tudo que restou provado nos autos, tenho por imperativo julgar PROCEDENTES os pedidos que se acham contemplados na presente ação ordinária para:

a) confirmando a liminar preteritamente concedida, condenar a demandada na obrigação de fazer consistente na cobertura integral do tratamento farmacológico do paciente portador de baixa estatura, nos exatos moldes requisitados pelo médico assistente, sob pena das astreintes já arbitradas.

b) imputar ainda a obrigação de indenizar a parte postulante, em aspecto compensatório pelos sofrimentos e danos extrapatrimoniais que valoro no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, CC), quantia a ser monetariamente corrigida pela Taxa SELIC (que já engloba correção e juros de mora) desde este *decisum* (Súmula 362, STJ).

Ressalto que, no caso concreto, não tendo ocorrido sequer notícia de solução de continuidade ao tratamento, fica afastada a imputação concreta da multa periódica.

Na oportunidade, extingo o presente feito por sentença com apreciação nuclear, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, imputando aos demandados o ônus sucumbencial representado pelas custas processuais e taxa judiciária em aberto, além de honorários advocatícios na ordem de 10% do valor da condenação, incluindo indenização e obrigação de fazer, tudo lastreado nos arts. 82, §2º, e 85, §2º, ambos do CPC/2015, e Súmula 199, TJPE.

Independentemente de nova intimação, deverá a parte demandada comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais no prazo de quinze (15) dias úteis contados do trânsito em julgado, sob pena de que se oficie imediatamente ao Comitê Gestor de Arrecadação do TJPE (ou quem lhe faça a vezes) para adoção das providências de cobrança cabíveis, incluindo a multa de 20%, na forma dos arts. 22 e 27, §3º, da nova lei de custas (Lei Estadual nº 17.116/2020).

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife-PE, data da assinatura digital.

Robinson José de Albuquerque Lima

Juiz de Direito

asms

Assinado eletronicamente por: **ROBINSON JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA**
11/07/2025 10:01:34
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **209259285**

25071110013458400000203766362

IMPRIMIR GERAR PDF